DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: LIBIA PEREA DE GALLARDO **Identificación** CC 29871839
Edad: 77 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	Y53	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

1	**452305**	**COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**	Y57	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES152 JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
452305 **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

Dx Postoperatorio: K635 POLIPO DEL COLON

Tipo de Herida: SUCIA **Tipo de Anestesia:** SEDACION **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 07:30:00 **Hora Final** 07:55:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: ERGE
SE INTRODUCE GASTROSCOPIO OLYMPUS
ESOFAGO:MUCOSA NORMAL ,PASO FÁCIL POR EL CRICOFARINGEO, PERISTALTISMO,
VASCULARIDAD,CONSERVADOS, LINEA A 38 COINCIDE CON LA IMPRESIÓN HIATAL.
ESTOMAGO: EXPLORADO HASTA PÍLORO INCLUYENDO RETROVISIÓN PARA PEQUEÑA CURVA Y FONDO GÁSTRICO NORMALES.
MUCOSA DE CUERPO Y ANTRO SIN ALTERACIONES.
PILORO FRANQUEABLE.
DUODENO: NORMAL HASTA SEGUNDA PORCIÓN
BIOPSIAS : NO
CONCLUSION:
ENDOSCOPIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS NORMAL
Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :
PROCEDIMIENTO BAJO SEDACIÓN ANESTESIOLOGA DRA RODRIGUEZ (FENTANILO, LIDOCAINA,
PROPOFOL).
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO,
PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE
REALIZADO POR JEISSON HINCAPIE
***INDICACIÓN: DOLOR ABDOMINAL
SE INTRODUCE COLONOSCOPIO OLYMPUS
INSPECCIÓN: NO ORIFICIOS FISTULOSOS, NO FISURAS, NO HEMORROIDES EXTERNAS, NO PLIEGUES CUTANEOS
REDUNDANTES.
TACTO RECTAL: ESFINTER NORMOTONICO, NO MASAS PALPABLES, DEDO DE GUANTE SALE LIMPIO.
ANOSCOPIA: CANAL ANAL SIN ALTERACIONES, LINEA DENTADA DE CONFORMACION HABITUAL, AMPOLLA RECTAL VACIA SIN
LESIONES MUCOSAS, RETROFLEXION SIN HEMORROIDES INTERNAS. COLONOSCOPIA: SE AVANZA HASTA ILEON DISTAL EL
CUAL SE ENCUENTRA CON MUCOSA DE CARACTERISTICAS NORMALES, EN RETIRADA SE EXPLORAN TODAS LAS PORCIONES DEL
COLON ENCONTRANDO ESCASOS ORIFICOS DIVERTICULARES EN COLON SIGMOIDES SIN APARENTES SIGNOS DE
COMPLICACION.ADEMAS SE OBSERVA POLIPO SEMI PEDICULADO DE UNOS 2 CM DE DIAMETRO EL CUAL SE DEBE PROGRAMAR

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

PARA RESECCION, SE ENCUENTRA OTRO POLIPO EN CIEGO DE UNOS 4 MM DE DIAMETRO DE ASPECTO ADNOMATOSO EL CUAL FUE RESECADO. PENDIENTE REPORTE PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES APARENTES. PREPARACIÓN BOSTON CD: 3, CT: 3, CI: 3
9/9.
BIOPSIA: POLIPO DE CIEGO
***CONCLUSIÓN:
1. DIVERTICULOSIS DEL COLON SIGMOIDES SIN DE COMPLICACION
2. POLIPO EN SIGMOIDES SEMI PEDICULADO DE APROX 2 CM DE DIAMETRO EL CUAL SE DEBE PROGRAMAR PARA RESECCION ENDOSCOPICA
3. POLIPO DE CIEGO DE APROX 4 MM SESIL DE ASPECTO ADENOMATOSO EL CUAL FUE RESECADO CON PINZA DE BIOPSIA PARA ESTUDIO HISTOLIGICO

Tejidos enviados a patología : SI [X] **NO** [ ]

BIOPSIA: POLIPO DE CIEGO

JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ
Reg. 1115066530
CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

***** FIN DEL REPORTE *****